

Рак легкого в географическом регионе «Нахичевань» Азербайджана

Солтанов А.А.

Национальный центр онкологии МЗ Азербайджанской Республики
(генеральный директор - академик РАМН РФ и НАНА Д.А.Алиев)

Рак легкого - наиболее распространенное по всему миру онкологическое заболевание [7,9], но распределение географически неоднородно [2,3]. Показатели заболеваемости рака легкого резко меняются между различными областями мира. Самые высокие показатели заболеваемости рака легкого у мужчин отмечены в Европе, особенно в центральной и Восточной Европе, и в северной Америке. В пределах Европы самые высокие мужские показатели заболеваемости отмечены в Венгрии и Польши, а самые низкие в Швеции и Мальте [4].

Отношение встречаемости рака легкого в двух отдельных регионах мира может составлять более 4 среди мужчин, и 5 среди женщин [8]. Из-за различий в регистрации онкологических заболеваний между странами, необходима предосторожность в интерпретации этих данных. Однако заметная разница не может быть объяснена низким уровнем диагностического обследования и профилактики.

Рак легкого в большинстве случаев характерен для развитых стран, а точнее для Северной Америки и Европы, и редко встречается в развивающихся странах, а именно в Африке и Южной Америке [5]. Имеется географическая изменчивость в тенденциях показателей заболеваемости и смертности рака легкого для мужчин и женщин. Более высокие показатели и более медленные снижения были замечены на Юге и Среднем Западе Америки. Среди мужчин показатель смертности рака легкого уменьшился в 43 из 50 государств и в округах Колумбии с 1996 по 2005, тогда как среди женщин, показатель смертности рака легкого уменьшился только в трех, и увеличился в 13 штатах [6].

Некоторые американские исследования [1] отмечают, что выбор методики проводимого исследования влияет на их конечные результаты. Анализ работ в различных штатах США выявил отсутствие зависимости частоты и формы злокачественных заболеваний от географии, социально-экономического статуса, этнической и половой принадлежности. Однако специалисты отмечают, что ведущим этиологическим фактором для злокачественных заболеваний легких является загрязнение атмосферного воздуха [10].

Изучение вопросов географии рака легких нельзя считать полностью законченными, и исследования в этом направлении оправданы. В связи, с чем изучена особенности рака легкого в отдельных 5 регионах республики, из которых «Нахичевань» является автономной республики Азербайджана (Нахичеванская АР) и расположено отдельно от основной территории Азербайджана, на границе с Турцией, Ираном и Арменией. Резко континентальный климат и сложный рельеф создают трудности для развития сельского хозяйства. Основу промышленности составляет производство продуктов питания. Эта отрасль представлена предприятиями по разливу минеральных вод, вина, плодоовощных консервов, мясомолочных продуктов, мукомольной промышленностью, добычей соли.

Рак легкого в географическом регионе «Нахичевань» Азербайджана

А.А.Солтанов

Национальный центр онкологии МЗ Азербайджанской Республики

Рак легкого наиболее распространенное по всему миру онкологическое заболевание, но распределение географически неоднородно. Показатели заболеваемости рака легкого резко меняются между различными областями мира.

В связи, с чем изучена особенности рака легкого в отдельных регионах республики Азербайджан. Анализированы данные истории болезни 982 больных раком легкого. Выявлено, что в регионе «Нахичевань» большинство 59,5% больных были сельскими жителями. Рак легкого часто 83,7% диагностированы в возрастных группах 50-69 лет независимо от клинко-анатомического роста опухоли. Самым частым гистологическим типом в этом регионе независимо пола больных раком легкого оказался плоскоклеточный рак, который отмечен у 55,6% больных. У большинства 78% больных диагностируются поздние стадии рака легких. Показатели заболеваемости и общие коэффициенты смертности рака легкого в регионе «Нахичевань» были больше общереспубликанских цифр.

Lung cancer in geographical region of Azerbaijan – Nakhichevan.

A. Soltanov

National Center of Oncology, Ministry of Public Health, Baku, Azerbaijan

Lung cancer is the most spread cancer around the world but its geographical distribution is not homogeneous. The morbidity values are sharply changing between different regions.

We studied lung cancer spread along Azerbaijan Republic. 982 case reports were analyzed. It was revealed that in Nakhichevan region the majority of patients – 59,5% were villagers. In 83,7% cases patients were 50-69 years old independently on clinical and anatomical features of the tumor. The most frequent histological type was squamous cell cancer – at 55,6% patients, 78% had late stage lung cancer. Morbidity and overall mortality rates of lung cancer in the region “Nakhichevan” were higher than republican rates.

Материалы и методы

Материалами исследования явились данные истории болезни 982 больных обследованных по поводу рака легкого в Национальном Центре Онкологии (НЦО) и Бакинском городском онкологическом диспансере (ГОД) с 1995 по

2003 г.г. Из-за малого числа больных в двух регионах, были дополнительно включены в исследование больные, обследованные в 2004-2010г.г. этих регионов. Для сбора информации использован единый кодификатор, который включал в себе 41 признак включающих ряд социально – медицинских показателей. Больные были распределены по 5 регионам, согласно их место жительства. Статистическую обработку полученных данных проводили с применением пакета программ *STATISTICA-6 Base* (Basic Statistical Analysis Methods) с использованием 2-Way table summary.

Для изучения показателей частоты заболеваемости, летальности и общие показатели смертности регионов был использован официальный статистический отчет Минздрава Азербайджанской Республики злокачественных новообразований за 2007 год. Официальный статистический отчет представлен Формой №7, которая утверждена указом № 43/5 от 27.11.2007 Государственным Комитетом Статистики Азербайджанской Республики. Учитывались количество первичных больных раком легкого, число населения и умершие от рака легкого в течение одного года за 2007 год.

Показатели заболеваемости, летальности и общий коэффициент смертности по отдельным регионам вычислены применяемыми формулами с помощью программы EXELL и Windows на персональном компьютере.

Результаты и обсуждение

Из 982 больных раком легкого 656 (66,8%) были жителями региона «Большой Кавказ», 129 (13,1%) региона «Куринская межгорная низменность», 67 (6,8%) региона «Малый Кавказ», 93 (9,5%) региона «Ленкорань», остальные 37 (3,8%) изучаемого региона «Нахичевань». (Табл.№1).

Из 37 больных этого региона 31 (83,8%) были лица мужского пола, 6 (16,7%) лица женского пола. 15 (40,5% из 37) больных этого региона были жителями городов, 22 (59,5% из 37) больных сельскими жителями. У 8 (21,6% из 37) больных были в анамнезе контакт вредными веществами на производствах или на рабочих местах, 29 (78,4% из 37) отрицали таких факторов.

Из 37 больных 10 (27%) были служащими, 12 (32,4%) пенсионерами, 13 (35,1%) не работали. 1 (2,7%) был водителем. Из 37 больных раком легкого этого региона 5 (20,8%) работали в административно - управленческих работах.

В возрастной градации моложе 40 лет был 1 (2,7%) больной, 40-49 лет 4 (10,8) больных, 50-59 лет 13 (35,1%) больных, 60-69 лет 18 (48,67%) больных, старше 70 лет 1 (2,7%) больной. (Табл.№2).

Независимо место жительства, в обеих группах преобладали больные в возрастной градации 60-69 лет (среди городских жителей 46,7%, среди сельских 50% больных).

Большинство 27 (73%) больных раком легкого этого региона были курильщиками. 17 (63%) из них помимо курения одновременно употребляли спиртные напитки. Только 10 (10,8%) больных отрицали вредные привычки в анамнезе как курения и употребления спиртных напитков. При анализе материала выявлено, что большинство 18 (48,6%) больных раком легкого с вредными привычками как курение и употребление спиртных напитков были сельскими жителями. (Таблица 3).

Как среди больных раком легкого городских жителей, так и сельских жителей большинство (соответственно: 60% и 81,8%) больных были курильщиками. Те, которые помимо курения одновременно употребляли спиртные напитки,

Табл.№1. Распределение больных раком легкого по полу и регионам Республики.

Пол болн.	«Большой Кавказ»	«Куринская межгорная низменность»	«Малый Кавказ»	«Нахичевань»	«Ленкорань»	Итого
муж.	585	120	60	31	84	880
	59,6%	12,2%	6,1%	3,2%	8,5%	89,6%
жен.	71	9	7	6	9	102
	7,2%	0,9%	0,7%	0,6%	0,9%	10,4%
Итого	656	129	67	37	93	982
	66,8%	13,1%	6,8%	3,8%	9,5%	100%

Табл.№2. Распределение больных по административно – территориальным принадлежностям и по возрастным градациям

Регион «Нахичевань»		Моложе 40 лет	40-49 лет	50-59 лет	60-69 лет	Старше 70 лет	Итого
Город. жители	Абс.числа	-	2	6	7	-	15
	В %	-	13,3	40	46,7	-	40,5
Сельск. жители	Абс.числа	1	2	7	11	1	22
	В %	4,6	9,1	31,8	50	4,5	59,5
Итого	Абс.числа	1	4	13	18	1	37
	В %	2,7	10,8	35,1	48,6	2,7	100

Табл.№3. Распределение больных по административно – территориальным принадлежностям и по наличию вредных привычек

Регион «Нахичевань»		Курит	Одновременно употр. спиртных нап. и табака	Вредн. привычки отрицают	Итого
Город. жители	Абс.числа	3	6	6	15
	В %	20	40	40	40,5
Сельские жители	Абс.числа	7	11	4	22
	В %	31,8	50	18,2	59,5
Итого	Абс.числа	10	17	10	37
	В %	27	45	27	100

Табл.№4. Распределение больных по административно – территориальным принадлежностям и по клинко-анатомическим формам роста опухоли

Р е г и о н «Нахичевань»		Централь ный рак	Перифери ческий рак	Атипичес кий рак	Итого
Город. жители	Абс.чис	9	6	-	15
	В %	60	40	-	40,5
Сельские жители	Абс.чис	14	6	2	22
	В %	63,6	27,3	9,1	59,5
Итого	Абс.чис	23	12	2	37
	В %	62,2	32,4	5,4	100

составили среди больных городских жителей 40%, среди сельских жителей 50%.

Центральный рак легких диагностирован у 23 (62,2%), периферический рак у 12 (32,4%), атипический рак у 2 (5,4%) больных этого региона. При сравнении групп больных раком легкого сельских и городских жителей выявлено, что в большинстве случаев диагностирован центральный рак легкого. Центральный рак диагностирован в 60% случаев среди городских жителей, 63,6% среди сельских больных (9 из 15 и 14 из 22 соответственно). Среди самих групп городских, и сельских больных периферический рак легких отмечено неодинаково часто. (Табл.№4).

Среди больных раком легкого этого региона у 8 (21,6%) диагностировано II стадия опухолевого процесса, у 19 (51,3%) III стадия и у 10 (27%) IV стадия опухолевого

процесса.

III стадия рака легкого диагностирована у 9 (60%) среди городских, у 10 (45,4%) среди сельских больных. IV стадия опухоли диагностированы одинаково часто как среди городских, так и среди сельских (у 4 (26,7%) среди городских, у 6 (27,3%) среди сельских) больных этого региона. (Табл.№5).

Табл.№5. Распределение больных по административно – территориальным принадлежностям и по стадиям опухолевого процесса.

Регион «Нахичевань»		II стадия	III стадия	IV стадия	Итого
Город. жители	Абс.числа	2	9	4	15
	В %	13,3	60	26,7	40,5
Сельские жители	Абс.числа	6	10	6	22
	В %	27,3	45,4	27,3	59,5
Итого	Абс.числа	8	19	10	37
	В %	21,6	51,3	27,1	100

Независимо места жительства большинство 19 (78,4%) больных обратились за медицинской помощью в специализированные онкологические учреждения в поздние III и IV стадии рака легкого этого региона, что делает необходимой повышения онкологической настороженности врачей общей лечебной сети.

Табл.№6. Распределение больных по административно – территориальным принадлежностям и по гистологическим типам опухолевого процесса.

Регион «Нахичевань»	П л о с к о - клет. рак	Аденокарцинома	Мелкоклет. рак	Др. виды	Итого
Город. жители	5	5	4	1	15
	33,3%	33,3%	26,7%	6,7%	41,7%
Сельские жители	15	1	1	4	21
	71,4%	4,8%	4,8%	19%	58,3%
Итого	20	6	5	5	36
	55,6%	16,7%	13,9%	13,9%	100%

У большинства 72,2% больных раком легкого этого региона была диагностирована плоскоклеточный рак и аденокарцинома легких. Как среди больных раком легкого городских жителей, так и среди больных сельских жителей плоскоклеточный рак отмечен часто. Среди больных раком легкого городских жителей у 5 (33,3%) установлен плоскоклеточный рак. Среди больных раком легкого сельских жителей плоскоклеточный рак был установлен у 15 (71,4%), недифференцированный рак, объединенный в группу «другие виды рака» у 4 (19%) больных. Так среди больных плоскоклеточным раком 25% были городские жители, остальные 75% сельские жители. Считаем, что, как и в других регионах, так и в этом регионе часто встречаемая гистологическая форма остается плоскоклеточный рак легкого. (Табл.№6).

Также были изучены показатели заболеваемости, летальности и смертности рака легкого по регионам республики. За 2007 год в этом регионе количество первичных больных раком легкого, которые состояли на учет, были 43, умершие в течение одного года 16, число умерших во

время отчета составило 34. Число населения за этот год составило 374632. Показатель заболеваемости для региона «Нахичевань» был больше общереспубликанских цифр, и составил 10,9 на 100 тыс. населения. Общий показатель летальности региона «Нахичевань» был низким общереспубликанских цифр и составил 39%. Общий коэффициент смертности для региона «Нахичевань» составил 0,09 на 100.тыс. населения, чуть больше общереспубликанских цифр.

Выводы

Основная часть 22 (59,5%) больных этого региона были сельскими жителями, 15 (40,5%) больных жителями городов.

Центральный рак легкого одинаково часто диагностирован у городских и сельских больных региона «Нахичевань» (60% и 63,6% соответственно).

Больные раком легкого этого региона часто (78%) обращались за медицинскую помощь в поздних - III и IV стадиях опухоли.

Независимо от пола в этом регионе часто (55,6%) диагностирована плоскоклеточная форма рака легкого.

Рак легкого часто (83,7%) в этом регионе диагностированы в возрастных группах 50-69 лет независимо от клинико-анатомического роста опухоли.

Показатель заболеваемости и общий коэффициент смертности для региона «Нахичевань» были больше, а общий показатель летальности был ниже общереспубликанских цифр.

Список литературы

1. Заридзе Д.Г. Эпидемиология и профилактика рака // Вопросы онкологии. -2001. -№9. -С.6-14.
2. Солтанов А.А. Показатели заболеваемости, летальности и общие коэффициенты смертности по регионам Азербайджана. Материалы VI съезда онкологов и радиологов стран СНГ. г.Душанба 2010. сmp.29
3. Bliss A, Cobb N, Solomon T, et al. Lung cancer incidence among American Indians and Alaska Natives in the United States, 1999-2004. Cancer 2008;113(5 Suppl):1168-78
4. Ferlay J., Autier P., Boniol M., Heanue M., Colombet M., Boyle P. Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006 Ann Oncol. 2007 Mar;18(3):581-92
5. Ghafoor A, Jemal A, Cokkinides V, et al. Cancer statistics for African Americans. CA Cancer J Clin. 2002;52:326-341.
6. Jemal A, Thun MJ, Ries LAG, et al. Annual Report to the Nation on the Status of Cancer, 1975-2005, Featuring Trends in Lung Cancer, Tobacco Use and Tobacco Control. Journal of the National Cancer Institute; Published online Nov. 25, 2008 Print issue Dec. 2, 2008. Vol. 100, No. 23.
7. Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Thun MJ. Cancer statistics, 2009. CA Cancer J Clin 2009;59:225-49.
8. National Cancer Institute (NCI), Cancer Statistics Branch, Division of Cancer Prevention, and Control. Cancer rates and risks. 1996 National Institutes of Health Bethesda, MD.
9. Parkin DM, Bray F, Ferlay J, Pisani P. Global cancer statistics, 2002. Unit of Descriptive Epidemiology, International Agency for Research on Cancer, Lyon, France. CA Cancer J Clin. 2005 Mar-Apr;55(2):74-108.
10. Toyooka S, Maruyama R, Toyooka KO, McLerran D, et al. Smoke exposure, histologic type and geography-related differences in the methylation profiles of non-small cell lung cancer. Int J Cancer. 2003 Jan 10;103(2):153-60.